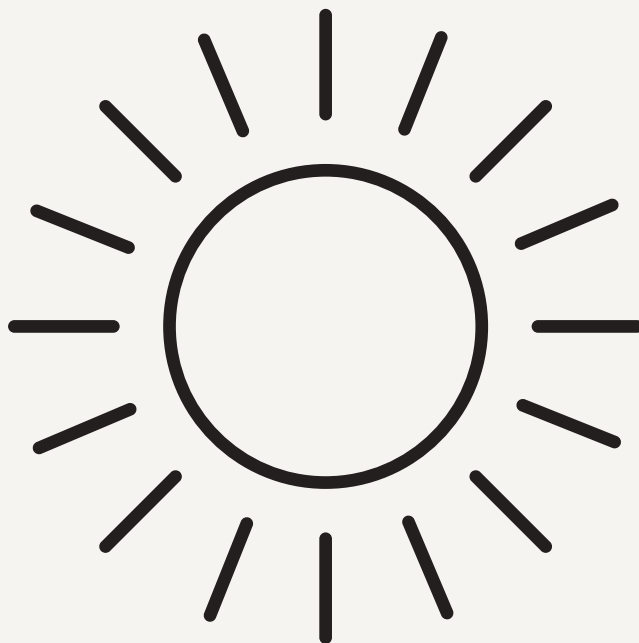


# **Rapport de recherche JJ-Traitement**



# **Proposition de protocole – Maintien en environnement non contaminé**

## **I. PRINCIPE GÉNÉRAL**

Jacky ne peut survivre sans un apport constant en dérivés actifs du NX-A. L'objectif n'est pas de "soigner", mais de substituer la dépendance respiratoire par un apport systémique contrôlé.

Je propose un traitement dérivé directement du sang de la patiente, exploitant le complexe Albumine-NX-A $\beta$  comme vecteur stable. L'idée est de maintenir une concentration minimale circulante suffisante pour éviter la défaillance, sans recourir à une exposition atmosphérique.

## **II. INJECTION PÉRIODIQUE**

**Nom de travail :** Sérum Nx- $\beta$  Stabilisé

**Composition :**

- Fraction plasmatique enrichie en Albumine-NX-A $\beta$  (extraite et purifiée)
- Stabilisateurs protéiques (éviter la dégradation du complexe)
- Tampon physiologique adapté au pH sanguin modifié de Jacky

**Administration :**

- Injection intraveineuse lente
- Fréquence : toutes les 4 heures
- Dose ajustée pour maintenir un seuil circulant minimal

**Effet recherché :**

- Apport direct de NX-A $\beta$  dans le sang
- Maintien de l'activité des érythrocytes modifiés
- Suppression du besoin d'inhalation de NX-A

## **III. Inhalateur concentré**

**Nom :** Diffuseur NX- $\beta$  microdosé

- Délivre une forme aérosolisée contrôlée du complexe
- Permet une absorption pulmonaire directe
- Moins invasif, mais plus instable (dégradation possible du composé)

**Utilisation :** en complément ou en cas d'impossibilité d'injection.

## **Proposition de protocole – Maintien en environnement non contaminé**

### **IV. ALTERNATIVE ORALE**

**Nom :** Capsule protéique Nx- $\beta$

- Encapsulation du complexe Albumine-NX-A $\beta$
- Résistance partielle aux sucs gastriques
- Biodisponibilité incertaine

Cette voie reste peu fiable à ce stade.

### **V. CONTRAINTES MAJEURES**

- Le traitement doit être produit à partir du sang de Jacky elle-même (compatibilité biologique critique)
- Toute altération du complexe Albumine-NX-A $\beta$  entraîne une perte d'efficacité
- Fenêtre thérapeutique étroite :
  - Sous-dosage → détresse immédiate
  - Surdosage → instabilité systémique

### **VI. EFFETS ATTENDUS**

- Maintien d'un état stable en air non contaminé
- Suppression du port constant d'un masque NX-A
- Dépendance au traitement toutes les 4 heures

### **VII. RISQUES**

- Dégradation du complexe hors environnement contrôlé
- Réactions imprévisibles si accumulation
- Nécessité d'un suivi strict et permanent

## **Proposition de protocole – Maintien en environnement non contaminé**

### **VIII. CONCLUSION**

Le traitement ne restaure pas une physiologie humaine classique.  
Il remplace l'environnement NX-A par une administration interne fractionnée.

Jacky resterait dépendante du NX-A, mais sous une forme contrôlée, portable et médicalisée, lui permettant d'évoluer en zone non contaminée sans assistance respiratoire externe.

Ce protocole constitue une solution viable à court terme, mais reste expérimental et instable.

*Silaz*

*Rozco*